

抗HER2療法

可逆性の高いType II心毒性(トラスツズマブ等)

TKI等

高血圧・血栓症・QT延長(スニチニブ等)

ICI

稀だが重篤な心筋炎(ニボルマブ等)

① 本日のポイント

- ☐ 抗HER2療法(トラスツズマブ・ペルツズマブ・T-DM1)= 可逆性の高いType II心毒性
- ☐ 血管新生阻害薬・TKI(ベバシズマブ・スニチニブ・ソラフェニブ等)= 高血圧・血栓症・QT延長
- ☐ ICI(ニボルマブ・ペムブロリズマブ・イピリムマブ等)= irAEとしての心筋炎
- ☐ ICI心筋炎:頻度1%未満だが致死率が高い。投与開始数週間以内の発症が多い
- ☐ 診断:トロポニン上昇+基準。劇症型/非劇症型で重症度を評価

② 薬剤師の実践ポイント

- ☐ ICI投与患者への症状モニタリング指導(倦怠感・動悸・息切れ・むくみ)
- ☐ 緊急性の見極めと、循環器医への迅速な情報共有

TAKE-HOME MESSAGE

抗HER2=可逆性のType II心毒性、TKI=高血圧・血栓症、ICI=稀だが重篤な心筋炎。